

29 - 05- Cancer du Rectum - Pr. Benelkhaïat

(0:00 - 0:14)

Donc, le cancer du rectum est un cancer très fréquent dans notre pratique quotidienne. Il pose un problème de santé publique. Les objectifs du cours d'aujourd'hui, tout d'abord connaître la gravité du cancer du rectum.

(0:15 - 0:34)

La gravité vient du fait que la tumeur est trop proche de l'appareil sphinctérien et donc la conservation de cet appareil sphinctérien pose un problème. L'acceptation de cette maladie pose beaucoup de problèmes. Donc, connaître les facteurs de risque.

(0:34 - 0:57)

Les facteurs de risque, on en a parlé. C'est la même chose que le cancer du colon, à savoir le problème des polypes qui peuvent dégénérer au fil des mois et des années, problème d'alimentation, problème de facteurs génétiques. Et on a vu que la prévention peut faire beaucoup de choses dans ce cas-là.

(0:58 - 1:19)

Et donc, le rôle du médecin dans les consignes qu'il peut déléguer à son malade et à la famille du malade sont très importantes. Connaître les moyens diagnostiques du cancer du rectum. Le diagnostic repose essentiellement sur une rectoscopie avec des biopsies qui va confirmer.

(1:19 - 1:40)

Donc, on revient sur un motif de consultation très fréquent, qui est la rectorragie, la perte du sang par l'anus. Elle est pas mal de fois prise pour un problème, un simple problème d'hémorroïdes. Donc, il ne faut pas passer et laisser passer ce symptôme-là.

(1:41 - 2:07)

Il faut insister sur l'exploration par la rectoscopie, un examen procto, donc complet, et fini par un prélèvement et un examen en APAT. Dernier objectif du cours d'aujourd'hui, c'est connaître les principes du traitement. Alors, la différence entre cancer du colon et cancer du rectum réside dans la prise en charge thérapeutique.

(2:07 - 2:34)

Si les facteurs favorisant et l'épidémiologie, c'est la même chose pour les deux cancers, colon et rectum, le rectum, premièrement, il est accessible à l'examen clinique par le toucher rectal. Deuxièmement, le traitement, il est totalement différent. La radiochimiothérapie occupe une place

prépondérante, et on va voir ça en live tout de suite.

(2:35 - 3:12)

Un rappel anatomique sur les travaux de Hylde et Anker, deux auteurs et deux chirurgiens suédois qui ont publié le mesorectum en 1982. Ces deux auteurs ont bouleversé la prise en charge thérapeutique. Je vous rappelle que le rectum est entouré par un tissu cellulo-grasieux sur toute sa hauteur, depuis le détroit supérieur jusqu'à la pointe du coccyx.

(3:12 - 4:09)

Et ce tissu, ce mesorectum, il a la forme d'un fer à cheval et il est enveloppé par une membrane qu'on appelle le fasciarecti. Le fait de disséquer, que le chirurgien dissèque exactement en dehors de ce fasciarecti, c'est qu'il respecte l'innervation des organes génitaux et l'innervation vésicale, et donc les problèmes d'impuissance sexuelle et les problèmes de perte urinaire après chirurgie ne se posent pratiquement plus si on respecte ce plan de dissection qui est le fasciarecti. La prise en charge est différente s'il s'agit d'un cancer du rectum chez le sexe masculin ou féminin.

(4:10 - 4:44)

Vous voyez que l'anatomie est un peu différente. Chez la femme, la présence de cette cloison rectovaginale qui sépare le rectum du vagin peut poser des problèmes et des difficultés sur le plan chirurgical. La localisation sur la face antérieure du rectum est un mauvais facteur pronostic par rapport à une localisation postérieure.

(4:45 - 5:13)

Celle postérieure est de meilleur pronostic. On va rappeler que le mesorectum est très développé sur la face postérieure du rectum alors que pratiquement il est inexistant en avant autant chez le sexe masculin que chez le sexe féminin. Voici une très belle image qui montre... Je déplace le curseur.

(5:13 - 5:33)

Le mesorectum est très développé en arrière et latéralement. Il est très mince en avant. Lorsque le cancer est antérieur sur la face antérieure du rectum, rapidement les cellules cancéreuses vont envahir les structures avoisinantes.

(5:33 - 5:46)

Chez le sexe masculin, on pense à la prostate et au vésicule séminale. Chez la femme, c'est la cloison rectovaginale. De même, le mesorectum est épais.

(5:46 - 6:01)

Il est très développé latéralement. Ce mesorectum protège contre l'extension et l'envahissement des organes voisins. Voici une lésion cancéreuse.

(6:01 - 6:24)

On voit qu'elle est confinée par ce mesorectum. C'est la membrane recti qui enveloppe le mesorectum. Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il faut diviser le rectum sur toute sa hauteur en trois étages.

(6:25 - 6:40)

Le premier étage, c'est le tiers inférieur. C'est le tiers inférieur. C'est les 5 cm de la ligne des cryptes jusqu'à 5 cm.

(6:40 - 6:58)

De 0 à 5 cm, c'est un cancer du tiers inférieur. De 5 cm à 10 cm, c'est un tiers moyen. De 10 cm à 15 cm de la marginale, c'est un tiers supérieur.

(6:59 - 7:31)

Le pronostic de ces trois cancers est différent. Quand la lésion siège au niveau du tiers inférieur, c'est-à-dire de 0, 0, c'est la ligne des cryptes, c'est-à-dire la ligne où s'ouvrent les glandes de Dessos et Hermann, qui entourent de manière circulaire l'anus. Lorsque le cancer siège au niveau du tiers inférieur, il pose un problème de conservation ou non de l'appareil sphinctérien.

(7:31 - 8:11)

Ce sont des cancers plus difficiles que le tiers moyen ou supérieur. Hormis cela, la première chose, quand vous, en tant que médecin, vous recevez un malade qui se plaint de cancer du rectum, c'est de situer la lésion cancéreuse par rapport à la ligne des cryptes, c'est-à-dire par rapport à la ligne 0. Si c'est un cancer de 0 à 5 cm, c'est un cancer du bas rectum. Si entre 5 et 10, c'est un cancer du moyen rectum, au-delà de 5 jusqu'à 15 cm, la prise en charge thérapeutique est différente.

(8:11 - 9:14)

Quand on a un cancer du haut rectum, la prise en charge rejoint celle du cancer du colon, c'est-à-dire que le cancer est chirurgical d'emblée, et on peut le confier au chirurgien d'emblée. Sinon, si le cancer siège au-dessous de 10 cm, le premier geste thérapeutique serait une radiochimiothérapie. Bien entendu, la prise en charge, on va voir ça tout à l'heure dans le traitement, comme on l'a vu dans la prise en charge du cancer du colon, c'est une prise en

charge multidisciplinaire qui nécessite une réunion de concertation entre médecins traitants, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes, et donc tout le staff se réunit et traite chaque cas à part du cancer du rectum.

(9:15 - 10:51)

Voici une vue endoscopique d'un néo, d'un cancer du rectum, c'est une forme bourgeonnante, probablement des polypes qui ont dégénéré, et donc c'est des tumeurs sessiles qui sont étendues sur le rectum et le cismoïde. Voici un rectoscope rigide qui permet aux médecins gastroentérologues de faire le diagnostic du cancer du rectum par rectoscopie, donc en général une préparation rapide s'impose, un lavement évacuateur, et l'examen doit se faire minutieusement, on doit observer bien sûr le tonus sphinctérien, la marge anale, comment elle se présente, et puis on va voir les différentes parois du rectum, antérieure, latérale, postérieure, et on va biopsier chaque lésion pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion anale. Comme introduction, les cancers colorectaux sont les premiers cancers digestifs de point de vue fréquence, ça pose un problème de santé publique, il n'est pas situé accessible au toucher rectal, contrairement au cancer du colon, qu'on a vu la séance dernière.

(10:52 - 11:40)

Pourtant le diagnostic au Maroc est encore posé au stade tardif parce que pas mal de malades sont pris, le 1er septembre c'est la rectoragie, et cette rectoragie malheureusement est prise à tort comme étant des hémorroïdes, et il y a le problème d'automédication qui se pose. La survie à 5 ans est relativement meilleure, à 40% ou plus avec les progrès faits surtout en chimiothérapie et en radiothérapie. Le diagnostic est fait par rectosigmoidoscopie, le traitement c'est la combinaison entre radiochimiothérapie et chirurgie.

(11:42 - 12:19)

Au cours des dernières années, on a assisté à une amélioration du pronostic du fait d'une prise en charge des lésions très cancéreuses, surtout des polypes, par les médecins, les collègues gastro-entérologues, donc cette prise en charge permet d'éviter la dégénérescence maligne. Sur le plan épidémiologique, il y a 12 000 nouveaux cas en France. 2% sont des tumeurs malignes et 25% de l'ensemble des cancers digestifs.

(12:19 - 13:01)

Il y a une légère prédominance masculine, 2 ans pour une femme, et c'est un cancer qui survient à un âge assez précoce, à partir de 45 ans. L'épidémiologie descriptive a été discutée la dernière fois au cours du cancer du colon. Donc le rôle de l'alimentation, en tant que médecin, vous devez expliquer aux patients qu'ils doivent manger sain, éviter une alimentation riche en graisse animale, beaucoup de fibres, beaucoup de légumes.

(13:02 - 13:29)

Les états précancéreux, ce sont surtout les polypes, les adénomes, qui peuvent être uniques ou multiples. La prise en charge doit être faite par les collègues gastro-entérologues. Maintenant, on peut réséquer facilement à l'aide de l'ence diathermique un polype, surtout lorsqu'il est pédiculé et qu'il a une base d'implantation qui n'est pas trop large.

(13:30 - 14:16)

J'insiste sur le fait qu'il faut toujours envoyer les pièces pour un examen anapathique détaillé pour étudier la base d'implantation et éliminer une dégénérescence maligne. Le siège du cancer par rapport à la marge anale, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, par détail qu'il faut dès le départ qualifier le cancer. Est-ce qu'il s'agit d'un bas rectum, d'un moyen rectum ou d'un haut rectum ? Il faut savoir que le rectum est péritonisé uniquement sur la partie supérieure, sur sa face antérieure et latérale.

(14:17 - 14:42)

Sinon, tout le reste est sous-péritonial et est enveloppé par le nézorectum. Sur le plan macroscopique, le cancer du rectum peut être soit un séro-végétan ou bien végétan. Parfois, il peut s'agir d'un adénome ou d'une tumeur villeuse transformée.

(14:43 - 15:10)

Sur le plan microscopique, le type histologique le plus fréquemment rencontré est l'adénocarcinome libercunien. Cet adénocarcinome peut être bien différencié comme il peut être moyennement différencié ou peu différencié. On sait très bien maintenant que plus l'adénocarcinome est bien différencié, plus il est de meilleure pronostique par rapport à celui qui est peu différencié.

(15:10 - 15:38)

Une forme qui survient surtout chez les sujets jeunes c'est l'adénocarcinome mycineux. Il survient donc chez les jeunes et il est de très mauvaise pronostique. Autres cancers qui sont vraiment rares sont le lymphome et le sarcome qui sont exceptionnels, mais la pronostique est très mauvaise dans le cas des sarcomes.

(15:38 - 15:57)

Un examen paraclinique qui est en vogue c'est l'écho-ondorectale. Voici ce que peut nous montrer l'image ondorectale. Une alternance de zones hyper-écogènes et de zones hypo-écogènes.

(15:58 - 16:23)

On part de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculuse jusqu'au mésorectum. L'examen avec l'écho-ondoscopie rend service énormément dernièrement. L'envahissement de la tumeur ou bien du cancer peut se faire par quantité, c'est-à-dire de proche en proche.

(16:24 - 17:43)

Premièrement il est localisé au niveau de la muqueuse, ensuite il va envahir la sous-muqueuse, ensuite la musculuse, et c'est à ce moment-là, quand il est encore superficiel, qu'il faut poser le diagnostic. Malheureusement, on voit encore des malades qui arrivent au stade avancé, localement avancé, voire même au stade d'occlusion intestinale basse avec une énorme distension abdominale à cause d'un diagnostic tardif et donc le pronostic serait très mauvais. On a insisté tout à l'heure sur la description par les deux auteurs suédois ou chirurgiens suédois en 1982 du mésorectum et donc la conservation de l'appareil sphinctérien mais surtout de l'innervation sympathique et parasympathique qui les filaments nerveux qui circulent en dehors du fasciarexi a rendu énormément service et a évité les problèmes d'impuissance observés après une chirurgie du rectum.

(17:43 - 18:37)

En arrière l'extension se fait vers l'espace présacré en avant vers les organes urogénitaux et latéralement vers le muscle releveur de l'anus et l'espace pélvirectal supérieur. Mais sinon l'envahissement peut se faire par voie lymphatique, le rectum dépend des ganglions lymphatiques mésentériques inférieures et donc au cours de la chirurgie un curage est très important. Voici une vue qui montre une vue stéréoscopique voici le diaphragme l'espace soufrénique droit le ligament falsifiant voici des métastases entre la limite du segment 7-8 et ici le segment 4 donc des métastases hépatiques.

(18:37 - 19:27)

Actuellement la prise en charge des malades avec des métastases hépatiques doit obéir aux règles de la prise en charge au cours des staffs multidisciplinaires et donc on peut même guérir il y a des cas guéris de métastases hépatiques ce n'est plus un facteur d'emblée de mauvais pronostics donc il faut staffer ces malades-là et chaque cas est à discuter à part. Donc les métastases se font par voie veineuse vers le premier organe privilégié c'est le foie. Deuxième organe qui peut être touché par les métastases d'un cancer du rectum c'est les métastases pulmonaires et puis les métastases osseuses.

(19:28 - 21:59)

Par voie lymphatique, le fait qu'un ganglion de troisièrs est touché est un facteur de mauvais pronostics. Voici la classification TNM des cancers du rectum le T1 lorsque la tumeur est limitée à la son muqueuse, une fois qu'elle touche la musculuse elle est dite T2 le T3 c'est la graisse péri-rectale et le T4 c'est les organes de voisinage. Le diagnostic positif il repose essentiellement

sur la clinique le malade va consulter pour des rectoragies.

Il ne faut pas attendre les signes cliniques tardifs que sont les ténèsmes, les douleurs rectales ou bien l'occlusion. Il faut faire le diagnostic à un stade précoce par le toucher rectal systématique chaque fois que le patient vient pour un problème des hémorroïdes il ne faut pas laisser passer l'occasion pour lui faire un toucher rectal et probablement faire le diagnostic d'une petite lésion qui peut cacher un cancer du rectum. Les ténèsmes, les épreintes c'est des signes sémiologiques tardifs en général c'est des T3 et des T4 aussi bien les troubles de transit et c'est des signes qui sont très tardifs.

Les formes révélées par des complications ne sont pas rares malheureusement c'est des formes révélées par des occlusions ou bien des foyers métastatiques des foyers secondaires et donc on peut poser le diagnostic à ce stade là. Donc l'examen clinique doit insister sur le toucher rectal. Le toucher rectal bien sûr le malade on doit lui expliquer tout d'abord l'examen on doit faire ce toucher rectal dans une salle calme, isolée bien sûr il faut évaluer le sphincter le tonus sphinctérien et à l'aide du toucher rectal bien sûr il faut examiner les parois du rectum bien sûr et au moindre doute bien sûr il faut compléter par un examen procto par la rectoscopie.

(22:00 - 23:17)

Le toucher rectal c'est une technique donc il nécessite une technique rigoureuse la vessie et le rectum doivent être vides d'abord, on décubite les dorsales sur un plan dur les cuisses fléchies. Il faut apprécier le siège, la base d'implantation d'une tumeur, son type macroscopique s'agit-il d'une tumeur bourgeonnante ou bien infiltrante, l'infiltration est-elle elle occupe uniquement une paroi latérale ou une paroi postérieure ou bien elle est circonférentielle et puis il faut terminer par un examen clinique complet à la recherche de métastases ou d'une extension à d'autres organes. La rectosigmoidoscopie explore tout le rectum et le sigmoïde.

Elle précise le siège exact de la tumeur et permet surtout des biopsies qu'il faut adresser à un collègue, à un confrère anatomopathologiste pour faire le diagnostic histopathologique. Le diagnostic différentiel c'est le diagnostic devant tout saignement de l'anus. Il faut pratiquer un toucher rectal donc complet et un examen complet.

(23:19 - 24:02)

Le bilan préopératoire bien sûr repose il faut évaluer le bilan d'extension l'échographie endorectale et l'échoendoscopie posent ou jouent un rôle très important dans cette extension loco-régionale. L'extension générale elle est évaluée par l'examen clinique complet bien sûr mais il ne faut pas laisser passer bien sûr l'échographie abdominale mais surtout une TDM actuellement corps entier, thoracique, abdominal et pelvien, un TAP. Donc il va évaluer l'extension exacte de la tumeur.

(24:03 - 28:05)

Le scanner pelvien peut diagnostiquer une grosse tumeur, des tumeurs sténosantes, des extensions aux organes de voisinage actuellement l'IRM est plus sensible que le scanner et elle est très intéressante surtout pour les stades T1 et T2 puisque ces stades T1 et T2 on peut même se passer de la radiochimiothérapie et discuter de ceci lors de la réunion du staff multidisciplinaire. Bien sûr, si signe d'appel urinaire, on peut compléter par une cystoscopie en cas de signe d'appel. La recherche d'une lésion associée, il faut compléter par une colonoscopie, il faut explorer tout le cadre colique depuis le sigmoïde jusqu'au sécum.

Si la tumeur est sténosante on peut prendre le relais par un lavement barité, sinon un coloscane. Donc il ne faut pas oublier les marqueurs tumoraux puisqu'ils vont nous donner une idée sur l'évolution même après la chirurgie, même après la résection de la tumeur, donc on a besoin d'un dosage initial, une référence d'antigène car sinon on est embryonnaire. Le bilan d'opérabilité bien sûr pour prendre en charge sur le plan chirurgical le patient, il faut évaluer le coeur, le poumon, l'état nutritionnel, l'état nutritionnel c'est la protidémie, c'est l'aluminémie, il faut évaluer la fonction rénale, donc toute cette évaluation elle est nécessaire avant le traitement.

Les objectifs du traitement d'un cancer du rectum, c'est de diminuer les récides loco-régionales, puisqu'on va revenir sur les travaux de Heald et Anker en 1982, l'avancée et la description du mesorectum, elle a permis une diminution des récides. Le principal problème du cancer du rectum se pose avec les récides après la chirurgie, et donc les moyens à notre disponibilité c'est la chirurgie, l'amputation abdominopérinéale, mais il faut dire que cette amputation est de moins en moins utilisée, d'une part elle n'est pas acceptée par les patients, maintenant c'est la résection antérieure, sinon il y a la colostomie de Prochamont qui est à visée palliative, ça peut être une alternative. Alors la radiothérapie, il y a plusieurs protocoles, il y a la radiothérapie pré-opératoire, on peut délivrer aux patients 45 grès, bien sûr étalés sur 9 semaines, suivi d'une chirurgie à 6 semaines après.

Le but de cette radiothérapie c'est de diminuer les récides locaux régionales, les indications c'est la radiothérapie elle est surtout indiquée pour les tumeurs T3, T4 et pour le rectum sous-péritoneal, c'est-à-dire de 0 à 10 cm le bas rectum et le moyen rectum. L'amputation abdominopérinéale elle est indiquée surtout pour les tumeurs qui sont proches de l'appareil sphinctérien mais il faut savoir que c'est une question de négociation, plus la tumeur est proche, plus elle pose un problème de conservation de l'appareil sphinctérien. Maintenant, on peut même accepter de conserver avec une distance entre l'appareil sphinctérien de 1 cm ou 1,5 cm on peut s'acharner à avoir une tranche de section saine et conserver l'appareil sphinctérien.

(28:07 - 30:04)

La technique chirurgicale s'appelle une résection antérieure quand la tumeur est au-delà de 5 cm c'est-à-dire au-delà de 5 cm de la ligne des cryptes les résultats de ce traitement la mortalité est autour de 5 % les complications qu'on peut avoir, on peut avoir des fistules anastomotiques, on peut avoir des troubles urinaires, des troubles sexuels le pronostic est très bon pour les tumeurs

T2 ou T1 il est de 60 % avec une survie à 5 ans et de 40 % lorsqu'on a un envahissement ganglionnaire N1. Après la chirurgie la surveillance et les cliniques aussi échographiques et radiologiques on se base également sur les antigènes carcino-embryonnaires et sur des coloscopies pour surveiller le colon. Voilà, donc le cancer du rectum nécessite un diagnostic précoce le diagnostic précoce c'est de faire attention chaque fois que le patient vient pour ce problème qui est très fréquent celui des hémorroïdes lorsque le patient pose lui-même le diagnostic et il se dit qu'il est porteur d'hémorroïdes, il faut faire un examen proctologique complet, il faut faire le toucher rectal et un examen rectoscopique pour ne pas passer à côté d'une tumeur débutante et laisser évoluer jusqu'au stade de tumeur évoluée donc je vous remercie.

(30:13 - 33:07)

Donc voici une très belle image des coloscopies avec une tumeur qui siège sur la paroi postérieure et latérale, la voici voici une image scanographique avec un cancer qui siège sur la paroi antérieure du rectum voici la prise en charge thérapeutique d'un cancer du moyen rectum donc la résection antérieure consiste à une résection avec une tranche de section saine donc une distance convenable qui sépare la tranche inférieure par rapport à la tumeur et une résection du sigmoïde avec bien sûr le curage mésantérique inférieur voici la colostomie elle consiste à l'abouchement du colon du sigmoïde à la paroi ça peut être soit un traitement définitif ou bien ça peut être un traitement en attendant la radiochimiothérapie et la prise en charge chirurgicale donc ici on voit les différents cancers, le bas rectum le moyen rectum et le haut rectum alors le bas rectum pose le problème de conservation de l'appareil sphinctérien le moyen rectum en général c'est une radiochimiothérapie première suivie d'une résection antérieure de la tumeur alors que le haut rectum il peut rejoindre la prise en charge thérapeutique des cancers du colon ici c'est une résection antérieure, voici l'anastomose et donc la conservation de l'appareil sphinctérien lorsque l'anastomose est basse située l'intervention peut être terminée par une ileostomie de protection en attendant la cicatrisation de l'anastomose donc ici l'ileostomie est temporaire c'est une ileostomie temporaire en attendant la cicatrisation de cette anastomose qui peut être difficile dans le cas du sexe masculin qui a un détroit supérieur très étroit donc certains patients peuvent être obèses, l'obésité aussi est un facteur de difficulté de la chirurgie donc voilà